

総論

抗がん剤の分類と作用機序

分類・副作用の評価

1 薬剤の分類マップ

細胞障害性抗がん薬 DNA合成・細胞分裂を障害	アルキル化薬・白金製剤 シクロホスファミド シスプラチン オキサリプラチン 代謝拮抗薬 5-FU S-1 カペシタビン ゲムシタビン 微小管・トポ阻害薬ほか パクリタキセル イリノテカン ドキソルビシン
分子標的薬 がんの特徴的な分子を狙う	小分子薬(経口) イマチニブ オシメルチニブ レンバチニブ 抗体薬 トラスツズマブ ペバシズマブ セツキシマブ 抗体薬物複合体(ADC) T-DXd T-DM1
免疫チェックポイント阻害薬 T細胞のブレーキを解除	抗PD-1抗体 ニボルマブ ベムプロリズマブ 抗PD-L1抗体 アテゾリズマブ デュルバルマブ 抗CTLA-4抗体 イビリムマブ
ホルモン療法 ホルモンの作用を遮断	乳がん タモキシフェン アナストロゾール レトロゾール フルベストラント 前立腺がん エンザルタミド アピラテロン リュープロレリン

☒ 経口薬(保険薬局で交付されることが多い) ☐ 注射薬

2 分類ごとの特徴と薬局での関わり

分類	標的	主な副作用	起こる時期	保険薬局での主な関わり
細胞障害性抗がん薬	分裂の速い細胞(非選択的)	骨髄抑制・悪心嘔吐・脱毛・口内炎	投与後の決まった時期(nadir等)	経口薬の服用日管理、nadir期の電話フォロー
分子標的薬	がんの特徴的な分子	標的に応じた特有の副作用(皮疹・高血圧・下痢・ILD等)	服用開始から継続的に	相互作用・服用時点の確認、スキンケア指導
免疫チェックポイント阻害薬	免疫のブレーキ(PD-1等)	irAE(皮膚・消化管・内分泌・肺など全身)	数週～数か月、終了後も	投与歴の把握、体調変化の聴取と受診勧奨
ホルモン療法	ホルモン受容体・産生	ほてり・関節痛・骨密度低下・血栓症	年単位の長期服用	アドヒアランス支援、骨・血栓の確認

3 副作用の特徴と発現時期

	投与日	1週	2週	1か月	3か月	1年～
● 過敏症(抗体薬・タキサン)	投与中～24時間					
● 悪心・嘔吐(細胞障害性)	～5日					
● 好中球減少(細胞障害性)		7～14日目				
● 皮疹・下痢(EGFR阻害薬)		服用1～2週から				
● 高血圧・蛋白尿(血管新生阻害薬)		開始数週				
● irAE(免疫チェックポイント阻害薬)				数週～数か月、終了後も		
● 間質性肺疾患				時期を問わず起こりうる		
● 関節痛・骨密度低下(ホルモン療法)					数か月～年単位	

☒ 重篤・特に注意 ☐ その他

押さえておきたいポイント

1. 抗がん剤は4分類(細胞障害性・分子標的・ICI・ホルモン)。分類ごとに副作用の種類も時期も異なる
2. 副作用はCTCAEのGradeで評価し、Gradeに応じてセルフケア支援・処方医への連絡・受診勧奨を判断
3. 病院はレジメン監査と投与、薬局は経口薬の管理と自宅での経過確認。情報共有が安全な治療の鍵